

Diarreia aguda · hidratação e zinco

Na diarreia aguda pediátrica, a hidratação salva vidas. Classifique desidratação e aplique planos A, B ou C; zinco reduz duração em contextos de risco.

Sinais de desidratação

Lembre - Sinais de desidratação

Olhos fundos, sede, elasticidade cutânea !“, mucosas secas, fontanela deprimida, diurese !“, letargia/ irritabilidade. Sangue no choque: extremidades frias, TE enchimento >2–3 s, pulso fino.

Memória obrigatória de pediatria de R1 e APS.



Conduta

- Manter leite materno; evitar antidiarréicos inibidores de motilidade
- Ondansetrona pode ajudar vômitos e sucesso da TRO em selecionados
- ATB: disenteria com sangue + febre / Shigella suspeita / cólera em surto — não rotina viral
- Zinco por 10–14 dias conforme protocolo OMS/MS em crianças elegíveis

Red flags

Sinal | Ação

- Sangue + toxemia | Avaliar bacteriana / internar
- Fontanela abaulada | Pensar meningite associada
- Bilioso / distensão | Obstrução — cirurgia
- Desnutrido grave | Protocolo específico de reidratação

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não use loperamida em crianças pequenas. No plano C, volume inicial de SF 0,9% em bolos e reavaliação — cuidado com desnutrido grave (risco de sobrecarga/ falência).

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Na diarreia aguda, classificação de desidratação + planos A/B/C + zinco formam o pacote OMS/MS que mais cai em prova.

Sem desidratação = A; com desidratação = B; grave/choque = C.

Diarreia - planos A/B/C

Hidratação primeiro

Plano A

Sem desidratação
SRO domiciliar
Manter dieta

Casa

Plano B

Desidratação
TRO 4h
Reavaliar

Unidade

Plano C

Grave / choque
SF EV
Internar

Urgência

Zinco por 10–14 dias reduz duração e gravidade em crianças elegíveis (protocolo local/OMS).

Zinco na diarreia

OMS / MS - conceito

Zn 10-14 dias

Complementa SRO; não substitui hidratação

Sinais !' plano

Achado | Plano

Bem, diurese ok, mucosas úmidas | A
Olhos fundos, sede, turgor !" | B
Letargia, enchimento lento, choque | C
Sangue + toxemia | Avaliar ATB / internar

Conduta

- Manter leite materno; evitar loperamida em crianças pequenas
- ATB só em disenteria selecionada / Shigella / cólera em surto — não rotina viral
- Ondansetrona pode ajudar sucesso da TRO em vômitos selecionados
- Desnutrido grave: protocolo específico de reidratação

Armadilha

Atenção - Armadilha

Vômito bilioso + distensão "" 'gastroenterite simples' — pense obstrução e avalie cirurgia.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

